facteurs de risques de l'asphyxie périnatale du nouveau-né à terme dans le service de néonatologie du Centre Hospitalier Universitaire Bogodogo

Nom du présentateur : Dr ILBOUDO Serge

Auteurs et coauteurs : **Ilboudo S[1]**, Sawadogo. M [1] TiendrebeogoG[1] Ouédraogo C[1], Ouedraogo N [1]. Bilgo A[1]. · Simporé B[1]. CisséA[1] **Ouédraogo/ Yugbaré S[1]**

Affiliations : [1] Département de pédiatrie, CHUB, Ouagadougou

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction (1)

- Asphyxie périnatale
- Altération des échanges gazeux utéro-placentaires
- Problème de santé publique
- OMS: ¼ de mortalité néo-natale (2012)
- Fréquence Hospitalière (Burkina Faso) : 28% (2013)

Objectif

❖ Général

Étudier l'asphyxie périnatale dans le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Bogodogo/Ouagadougou au Burkina Faso de septembre 2020 à septembre 2022

Objectif

- OS 1: Décrire la prévalence de l'asphyxie périnatale
- OS 2: Décrire les aspects cliniques de l'asphyxie périnatale
- OS 3: Décrire les aspects para cliniques de l'asphyxie périnatale
- OS 4: Apprécier la prise en charge de l'asphyxie périnatale
- OS 5: Déterminer les facteurs de risque de l'asphyxie périnatale

Matériel et méthodes(1/1)

- Cadre de l'étude: CHUB/Service de pédiatrie
- Type d'étude: Étude transversale Analytique descriptive
- Période d'étude: Septembre 2020 à Septembre 2022
- Population d'étude: 0–28 jours hospitalisés service pédiatrie
- Critères d'inclusion:
- Nouveau-nés à terme réanimés à la naissance

Résultats(1/12)

- **Données Sociodémographiques**
- **Nouveau-né**
- Age Médian de 0 j (0 – 18 j) Sex-Ratio 1.84
- **Mères**
- Age Moyen 25.5 ans milieu urbain 81.42 %, FAF 67.26%

Résultats(2/12)

- **Données Cliniques**
  - **Données sur la grossesse**
  - Monofoetale dans 87.10%
  - Soins prénataux : ≥ 4 dans 63.49% avec TPI= 88.69%, F/AF=90.07%; VAT=60.31%
  - Manifestations Pathologiques =22.22% , Anémie++

Résultats (3/12)

- **Données Cliniques**
- **Données sur l'accouchement**

✓Maternité CHU-B 81.82% VB=67.85% Césarienne= 32.28% (SFA)

✓Liquide Amniotique Anormal= 51.59%

Résultats (4/12)

❑ Données sur le Nouveau-né

Score d'Apgar : < 7 à la 5ème min = 36.16%

- Etat du NNE naissance :Absence de cri= 92.3%

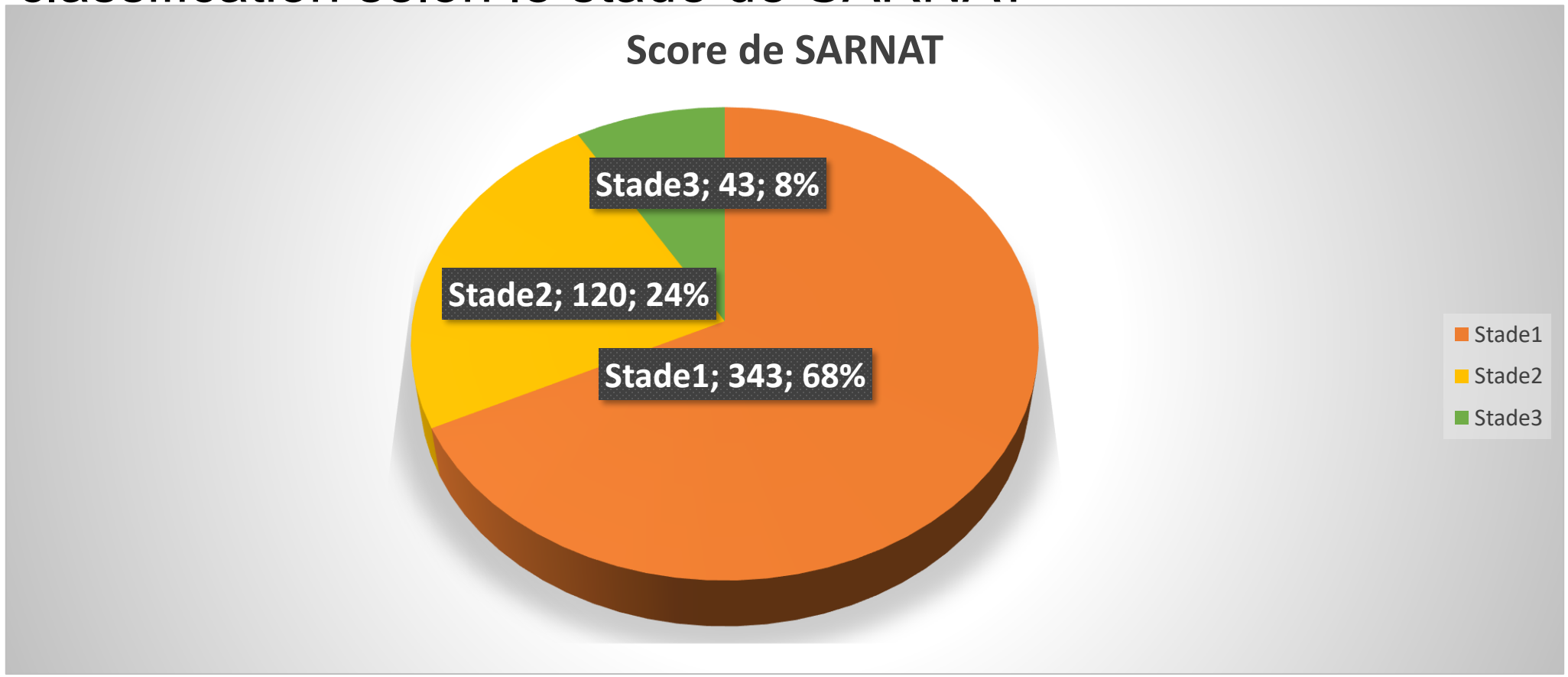
  Hypotonique= 80.83%

- Etat du NNE : Conscience altérée = 23.3%

- RA émoussés= 97.8%

Résultats (5/12)

- classification selon le stade de SARNAT



Résultats(6/12)

Données para cliniques

❑ Biologie

- Taux d'Hb : ‹ 14g/dl = 45.65%
- Créatininémie plasmatique : › 90 mmol/l = 9.05%
- Taux de bicarbonate : ‹ 14 mmol/l = 46.56%
- Glycémie : Hypoglycémie= 28.35%
- Hyperglycémie= 4.91%

Résultats(7/12)

Données para cliniques

- **Imagerie**
- **ETF**
- Hydrocéphalie = 7.87%
- Hémorragie intra-ventriculaire = 2.36%
- Œdème cérébral diffus = 0.79%

Résultats(8/12)

❑ Données para cliniques

- **Imagerie**
- **Échographie cardiaque**
  - CA de volume moyen= 46.67%
  - CIA type ostium secundum= 33.33%
  - Tétralogie de Fallot= 8.33%
  - Hyperplasie septale= 8.33%
  - Hypertrophie ventriculaire gauche= 8.33%

Résultats(9/12)

Imagerie

- **Radiographie Thoracique**
- Bronchopathie bilatérale= 45.83%
- Pneumopathie alvéolo-interstitielle= 33.33%
- Broncho-pneumopathie= 16.67%
- Fracture de la clavicule= 4.17%

Résultats(10/12)

Données thérapeutiques

- Phénobarbital = 64.46%
- Oxygénothérapie = 38.34%
- Antibiothérapie= 97.63%
- SENN= 98.81%
- Mise sous lampe Chauffante= 29.44%

Résultats (11/12)

❑ Modalités Évolutives

- ❑ Complications: Convulsions= 31.96% ; Infections=27.84%

  Anémies= 20.61%

- ❑ Létalité intra hospitalière= 15.81%

- ❑ Durée Moyenne d'hospitalisation: 6.54j (ET=6.55j;1-60j)

Résultats (12/12)

❑ Facteurs pronostiques de décès Multivariée

- Non à jour du Vaccin Antitétanique: $p < 0.0001$
- Durée du travail prolongé: $p = 0.04$
- Tonus passif: $p = 0.009$
- Score SARNAT: $p < 0.011$

Conclusion (1/2)

- Asphyxie périnatale= Problème de santé publique
- Gravité: séquelles / Décès
- Diagnostique = Facile
- Notre étude: NN à terme 69.50% des cas d'APN
- Facteurs de risque (SARNAT, Durée du travail, VAT,Tonus)

Conclusion (2/2)

- Prévention = PEC codifiée de la grossesse-accouchement-période périnatale
- Collaboration Obstétricien-Sage femme-Réanimateurs-pédiatre

Merci pour votre attention